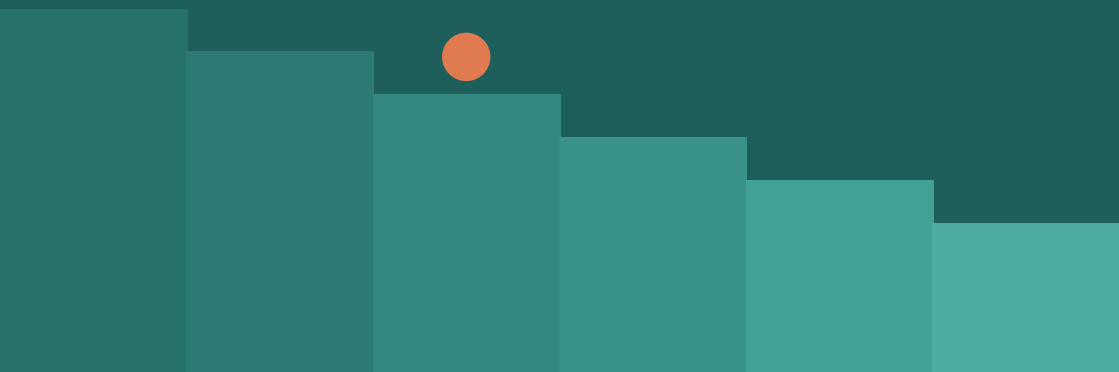
GUÍA PRÁCTICA PARA PERDER PESO ENTRE 100 Y 150 KG

Bajando un escalón

Un paso pequeño cada vez.
Sin dietas imposibles. Sin culpa.

Alimentación · Movimiento · Sueño · Mente · Plan de 12 semanas



Bajando un escalón

Guía práctica para perder peso entre 100 y 150 kg

Aviso importante. Este libro ofrece información general sobre hábitos saludables. No es un tratamiento ni sustituye a tu médico, enfermera o dietista-nutricionista. Si tienes diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, renal o hepática, apnea del sueño, estás embarazada o tomas medicación, consulta antes de cambiar tu alimentación o tu actividad física.

Índice

— Cómo usar este libro

1 Empezar donde estás

2 Antes de subir: la revisión médica

3 La energía, sin obsesionarse

4 El plato escalón

5 Hambre, antojos y emociones

6 Moverse con un cuerpo grande

7 Sueño, estrés y entorno

8 Mesetas, tropiezos y recaídas

9 Cuando hace falta más ayuda

10 El plan de 12 semanas

11 Herramientas y registros

— Epílogo: mirar hacia abajo

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este libro

Este libro no te va a pedir que cambies tu vida el lunes. Te va a pedir algo mucho más modesto y mucho más eficaz: que bajes un escalón. Un hábito. Una semana. Y luego otro.

Está escrito para personas que pesan aproximadamente entre 100 y 150 kilos. A ese peso, el cuerpo y la vida diaria tienen particularidades que los libros de dietas suelen ignorar: articulaciones que se quejan, cansancio, ropa y espacios que no están pensados para ti, miradas ajenas y, a menudo, una larga historia de intentos fallidos. Nada de eso es un fallo personal. Es el punto de partida.

Las tres reglas de la escalera

- **Un escalón cada vez.** Cada semana añades o ajustas un único hábito. Si lo intentas todo a la vez, lo normal es abandonarlo todo a la vez.
- **El escalón tiene que ser pequeño.** Si dudas de si podrás mantenerlo seis meses, hazlo más pequeño.
- **Caer no es volver abajo del todo.** Un mal día es un mal día, no el final del plan.

Puedes leer el libro de corrido o ir directamente al plan de 12 semanas (escalón 10) y volver a los capítulos cuando los necesites. Al final encontrarás registros para fotocopiar o copiar en una libreta.

No necesitas ver el final de la escalera.
Solo el siguiente escalón.

ESCALÓN 1

Empezar donde estás

Cuando se pesa 130 kilos, la cifra «ideal» que aparece en las tablas puede parecer tan lejana que desanima antes de empezar. Por eso este libro cambia la meta: no buscamos un peso perfecto, buscamos bajar el primer escalón.

El poder del 5–10 %

Perder entre un 5 y un 10 % del peso inicial produce beneficios de salud medibles en la mayoría de personas con obesidad: baja la tensión arterial, mejora el control del azúcar, disminuyen los triglicéridos, se alivia la carga sobre rodillas y caderas, y a menudo se duerme y se respira mejor.

Peso inicial	5 %	10 %
100 kg	5 kg	10 kg
115 kg	5,8 kg	11,5 kg
130 kg	6,5 kg	13 kg
150 kg	7,5 kg	15 kg

Fíjate: para alguien de 130 kg, el primer gran escalón son unos 6–7 kilos. Es un objetivo alcanzable en pocos meses sin medidas extremas.

Más allá de la báscula

La báscula es una herramienta, no un juez. Mide también otras cosas que cambian antes y motivan más:

- Perímetro de cintura (a la altura del ombligo, una vez al mes).
- Cuántos minutos puedes caminar sin parar.

- Cómo duermes y cuánta energía tienes por la tarde.
- Cómo te queda la ropa, si subes escaleras con menos esfuerzo.
- Resultados de analítica y tensión arterial.

Escalón práctico

Escribe en una hoja: tu peso de hoy, tu cintura, cuántos minutos caminas seguidos y tres cosas que te gustaría poder hacer con más facilidad dentro de seis meses. Guárdala. La volveremos a mirar.

ESCALÓN 2

Antes de subir: la revisión médica

A partir de 100 kilos es muy recomendable hablar con tu médico de atención primaria antes de cambiar la alimentación o empezar a hacer ejercicio. No es un trámite: hay situaciones en las que adelgazar exige ajustar medicación, y otras que conviene descartar.

Qué pedir o comentar en consulta

- Tensión arterial y, si procede, electrocardiograma.
- Analítica: glucosa y hemoglobina glucosilada (HbA1c), colesterol y triglicéridos, función de hígado, riñón y tiroides.
- Si roncas fuerte, te despiertas cansado o te quedas dormido de día: valorar **apnea del sueño**.
- Dolor de rodillas, caderas o espalda que limite el movimiento.
- Toda la medicación que tomas, incluidos suplementos.
- Si existe la posibilidad de derivarte a nutrición, endocrinología o fisioterapia.

> **Atención con la medicación**
> Si tomas fármacos para la diabetes (sobre todo insulina o sulfonilureas) o para la tensión, al comer menos y moverte más pueden aparecer bajadas de azúcar o de tensión. **No cambies ni suspendas nada por tu cuenta**: tu médico debe ir ajustando las dosis.

Señales para parar y consultar

- Dolor u opresión en el pecho, falta de aire desproporcionada o mareo durante el esfuerzo.
- Palpitaciones fuertes o irregulares.
- Dolor articular que empeora día a día o hinchazón de una pierna.
- Sudor frío, temblor o confusión (posible hipoglucemia si eres diabético).

Una buena relación con tu equipo sanitario es uno de los escalones más importantes. Si alguna vez te has sentido juzgado en consulta, tienes derecho a pedir que se hable de tu salud con respeto y con datos.

ESCALÓN 3

La energía, sin obsesionarse

Para perder peso el cuerpo necesita gastar algo más de energía de la que recibe. Es un principio sencillo, pero aplicarlo con dietas muy estrictas casi siempre sale mal: provoca hambre intensa, pérdida de músculo, cansancio y, al final, efecto rebote.

Un déficit moderado

La recomendación habitual para personas con obesidad es un déficit moderado, de alrededor de 500 kcal al día respecto a lo que gastas. A pesos altos, eso suele traducirse en una pérdida de entre **0,5 y 1 kg por semana**, a veces algo más al principio por pérdida de líquidos.

La buena noticia: a 100–150 kilos el cuerpo gasta bastante energía solo por existir y moverse. No necesitas pasar hambre para conseguir ese déficit. Cambiar las bebidas azucaradas por agua, reducir los ultraprocesados y servir raciones algo más pequeñas ya puede ser suficiente durante meses.

Por qué no contar calorías al principio

Contar calorías funciona para algunas personas, pero a muchas les genera ansiedad o lo dejan a las dos semanas. Este libro propone empezar con **estructura** (horarios, plato, bebida) en lugar de números. Si tras unos meses te estancas, un dietista-nutricionista puede calcular contigo una cifra concreta.

Lo que conviene evitar

Dietas de muy bajo contenido calórico sin supervisión médica, ayunos prolongados, «detox», batidos milagro, pastillas sin receta o eliminar grupos enteros de alimentos sin motivo. Con un cuerpo grande, perder demasiado rápido aumenta el riesgo de pérdida de músculo, piedras en la vesícula y rebote.

La regla del 80/20

Si el 80 % de lo que comes durante la semana sigue el plan, el 20 % restante —una cena con amigos, un postre de cumpleaños— no arruina nada. La constancia gana a la perfección.

ESCALÓN 4

El plato escalón

En lugar de una dieta, vas a aprender a montar un plato. Sirve para casa, para el táper y para el restaurante.

Parte del plato	Qué poner	Ejemplos
½ plato	Verduras y hortalizas	Ensalada, judías verdes, brócoli, pisto, calabacín, tomate
¼ plato	Proteína	Pollo, pavo, pescado, huevos, legumbres, tofu, ternera magra
¼ plato	Hidratos de calidad	Patata cocida, arroz o pasta integral, pan integral, legumbres
Aparte	Grasa saludable con medida	Una cucharada de aceite de oliva, unas nueces
Para beber	Agua	Agua, con gas, infusiones sin azúcar

Cinco escalones de alimentación

- **Bebe agua.** Refrescos, zumos y alcohol aportan mucha energía sin saciar. Es el cambio con más impacto y menos sacrificio.
- **Proteína en cada comida.** Sacia, protege el músculo mientras pierdes peso y reduce el picoteo.
- **Medio plato de verdura** en comida y cena, aunque sea congelada o en conserva.
- **Platos más pequeños.** Sirve en la cocina y no lleves la fuente a la mesa.
- **Menos ultraprocesados.** Bollería, snacks, embutidos grasos y comida rápida, mejor ocasionales.

Horarios

No hay un número mágico de comidas. Lo importante es tener una estructura estable: por ejemplo, desayuno, comida y cena, con una merienda planificada si la necesitas. Saltarse comidas suele terminar en atracones por la noche.

Un día de ejemplo

Momento	Propuesta
Desayuno	Tostada integral con tomate y aceite + 2 huevos o queso fresco + café o té
Comida	Lentejas con verduras + ensalada grande + fruta
Merienda	Yogur natural con un puñado de frutos secos
Cena	Merluza al horno con patata y judías verdes

Comer fuera sin miedo

Elige plancha, horno o guiso antes que fritos y rebozados; pide la salsa aparte; comparte el postre; agua en la mesa. Y disfruta: comer con otras personas también es salud.

ESCALÓN 5

Hambre, antojos y emociones

Muchas personas no comen de más por falta de información, sino porque la comida cumple otras funciones: calma, acompaña, premia, distrae. Reconocerlo no es una debilidad; es el comienzo del cambio.

Hambre física o hambre emocional

Hambre física	Hambre emocional
Aparece poco a poco	Aparece de golpe
Cualquier comida sirve	Pide algo concreto (dulce, salado, crujiente)
Se calma al comer	Sigue aunque estés lleno
No deja culpa	Suele dejar culpa

La pausa de 10 minutos

Cuando aparezca un antojo fuerte, no te lo prohíbas: aplázalo 10 minutos. Bebe un vaso de agua, sal a dar una vuelta o llama a alguien. Si después sigues queriéndolo, cómelo sentado, en un plato y despacio. Muchas veces la intensidad baja sola.

Herramientas que ayudan

- Anota qué sentías antes de comer sin hambre (aburrimiento, enfado, cansancio, soledad).
- Ten una lista de cinco cosas que te calman y no son comida.
- No tengas a la vista lo que sabes que te cuesta controlar.
- Habla contigo como hablarías con un amigo que lo está intentando.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si con frecuencia comes grandes cantidades en poco tiempo sintiendo que pierdes el control, o si la comida, el peso o tu cuerpo te generan mucho sufrimiento, coméntalo con tu médico. Existen tratamientos psicológicos eficaces, y pedirlos es un escalón valiente.

ESCALÓN 6

Moverse con un cuerpo grande

El ejercicio por sí solo hace perder menos peso de lo que se cree, pero es decisivo para **mantenerlo**, proteger el músculo, mejorar el ánimo, el azúcar y el corazón. La clave a 100–150 kg es empezar suave y cuidar las articulaciones.

Las mejores opciones para empezar

- **Caminar**: en llano, con buen calzado. Empieza por 5–10 minutos, aunque sea en varios ratos al día.
- **Agua**: caminar en la piscina o aquagym. El agua descarga peso de las articulaciones.
- **Bicicleta estática** con sillín cómodo y resistencia baja.
- **Ejercicios en silla**: ideales si caminar duele.

Rutina de fuerza en silla (2–3 días por semana)

Ejercicio	Cómo	Repeticiones
Sentarse y levantarse	De una silla firme, con apoyo de manos si hace falta	2 × 6–10
Flexiones en pared	Manos en la pared, acercar y alejar el pecho	2 × 8–12
Elevación de rodilla	Sentado, subir una rodilla y luego la otra	2 × 10 por lado
Remo con banda	Banda elástica sujeta al frente, tirar hacia el pecho	2 × 10–12
Puntillas	De pie, agarrado al respaldo, subir talones	2 × 10–15

La escalera del movimiento

Aumenta solo una cosa cada semana: o los minutos, o los días, nunca las dos a la vez. Una progresión razonable es sumar 5 minutos semanales de caminata hasta llegar a unos 150 minutos semanales (por ejemplo, 30 minutos cinco días).

Usa la **prueba del habla**: deberías poder hablar mientras te mueves, aunque no cantar. Si no puedes decir una frase completa, baja el ritmo.

> **Cuida tus apoyos**
> Calzado con buena amortiguación, calcetines sin costuras, ropa que no roce. Si aparecen rozaduras o heridas en los pies —especialmente si eres diabético—, revísalas a diario y consulta.

Moverse fuera del ejercicio

Levántate cada 30–45 minutos si trabajas sentado, aparca un poco más lejos, sube un piso por escalera y baja en ascensor. Todo suma, y a tu peso cada paso cuenta más que para una persona pequeña.

ESCALÓN 7

Sueño, estrés y entorno

Dormir mal aumenta el hambre al día siguiente, sobre todo de dulces y harinas, y reduce la energía para moverse. El estrés crónico empuja en la misma dirección. Por eso son escalones tan importantes como la comida.

Dormir mejor

- Horario estable para acostarte y levantarte, también los fines de semana.
- Pantallas fuera la última media hora.
- Cena ligera y al menos dos horas antes de acostarte.
- Habitación oscura, fresca y silenciosa.
- Si roncas, haces pausas al respirar o te levantas agotado: consulta por apnea del sueño. Tratarla cambia la vida.

Manejar el estrés

Respiración lenta (inspira en 4 tiempos, espira en 6) durante dos o tres minutos, paseos al aire libre, hablar con alguien de confianza, reducir compromisos innecesarios. No hace falta meditar una hora: basta con pausas pequeñas y frecuentes.

Diseña tu entorno

Es más fácil cambiar la cocina que la fuerza de voluntad. Fruta lavada a la vista, agua en la mesa, verdura congelada en el congelador, los ultraprocesados fuera de casa o en un armario alto. Haz la compra con lista y sin hambre.

Tu gente

Cuéntale tu plan a una o dos personas que te apoyen. Pide cosas concretas: «no me ofrezcas postre», «acompáñame a

caminar los martes». Y aléjate, en lo posible, de los comentarios que te hacen daño.

ESCALÓN 8

Mesetas, tropiezos y recaídas

En algún momento la báscula se parará. Es normal y le pasa a todo el mundo: el cuerpo pesa menos, gasta algo menos y se adapta. Una meseta no significa que el plan haya dejado de funcionar.

Si llevas 3–4 semanas sin bajar

- Revisa las bebidas, los picoteos y las raciones: con el tiempo tienden a crecer sin darnos cuenta.
- Anota todo lo que comes durante una semana, solo para observar.
- Añade un poco de fuerza: el músculo ayuda a gastar.
- Mira las otras medidas: ¿baja la cintura?, ¿caminas más? Puede que estés cambiando aunque el peso no lo refleje.
- Consulta con tu profesional sanitario si el estancamiento es largo.

El tropiezo no es la caída

Un fin de semana de excesos no deshace meses de trabajo. El problema no es el tropiezo, sino el pensamiento «ya lo he estropeado, da igual». Cuando ocurra, vuelve al plan en la siguiente comida, no el lunes.

Plan de recaída (rellénalo hoy)

Mis señales de alarma son: _____
Lo primero que haré será: _____
La persona a la que avisaré es: _____
El escalón mínimo que mantendré pase lo que pase:
_____

ESCALÓN 9

Cuando hace falta más ayuda

La obesidad es una enfermedad crónica con un componente biológico importante. Para algunas personas, los cambios de hábitos son suficientes; para otras, no lo son, y eso no es un fracaso de voluntad. Existen tratamientos médicos que se suman a los hábitos, no los sustituyen.

Tratamiento farmacológico

En los últimos años han aparecido medicamentos que reducen el apetito y ayudan a perder peso de forma significativa, como los de la familia de los análogos de GLP-1. Requieren **prescripción y seguimiento médico**, tienen efectos secundarios y no son adecuados para todo el mundo. Nunca los compres por internet ni los uses sin receta.

Cirugía bariátrica

En personas con obesidad grave, sobre todo si hay enfermedades asociadas como la diabetes, la cirugía puede ser una opción. Implica una evaluación completa por un equipo especializado y un compromiso de seguimiento de por vida. Todo lo que aprendes en este libro sigue siendo necesario después de operarse.

El equipo

Médico de familia, endocrinólogo, dietista-nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Pide derivación si crees que puede ayudarte. Bajar escalones es más fácil acompañado.

ESCALÓN 10

El plan de 12 semanas

Cada semana tiene un escalón nuevo. Mantén los anteriores y añade solo el de la semana. Si uno te cuesta, repítelo una semana más: la escalera espera.

Sem.	Escalón de la semana	Movimiento
1	Revisión médica y registro inicial (peso, cintura, minutos caminando)	Caminar 5–10 min al día
2	Cambiar las bebidas azucaradas y el alcohol por agua	10 min al día
3	Desayuno con proteína	10–15 min + silla 2 días
4	Medio plato de verdura en la comida	15 min + silla 2 días
5	Medio plato de verdura también en la cena	15–20 min + silla 2–3 días
6	Platos más pequeños y servir en la cocina	20 min + silla 3 días
7	Lista de la compra y despensa sin ultraprocesados a la vista	20–25 min + silla 3 días
8	La pausa de 10 minutos ante los antojos	25 min + silla 3 días
9	Horario de sueño fijo y cena temprana	25–30 min + silla 3 días
10	Picoteo planificado: una merienda fija, nada más	30 min, 5 días
11	Plan para comer fuera y fines de semana	30 min + algo en agua o bici
12	Revisión: medidas, logros y elegir los escalones de los próximos tres meses	Mantener

Cómo pesarte

Una vez por semana, el mismo día, por la mañana, en ayunas y con poca ropa. Apunta el dato y olvídalo hasta la semana siguiente. Si pesarte te angustia, puedes hacerlo cada dos semanas o centrarte en la cintura.

Al terminar la semana 12

Vuelve a la hoja que escribiste en el escalón 1. Compara peso, cintura, minutos caminando y esas tres cosas que querías hacer con más facilidad. Celébralo —con algo que no sea comida— y elige tus próximos escalones.

ESCALÓN 11

Herramientas y registros

Registro semanal

Semana	Peso	Cintura	Min. caminados	Escalón cumplido (días)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Diario de antojos

Día y hora	Qué sentía	Qué hice	¿Cómo me fue?

Lista de la compra base

Grupo	Productos
Verduras	Tomate, lechuga, calabacín, brócoli, zanahoria, pimiento, verdura congelada
Frutas	Manzana, plátano, naranja, fruta de temporada
Proteínas	Huevos, pollo, pavo, pescado blanco y azul, latas de atún o sardinas
Legumbres	Lentejas, garbanzos, alubias (secas o cocidas en bote)
Hidratos	Pan integral, arroz, pasta integral, patatas, avena
Lácteos	Yogur natural, leche, queso fresco
Otros	Aceite de oliva virgen extra, frutos secos naturales, especias, infusiones

Mis cinco cosas que calman y no son comida

1	
2	
3	
4	
5	

EPÍLOGO

Epílogo: mirar hacia abajo

Cuando subimos una escalera, rara vez miramos atrás. Pero de vez en cuando merece la pena hacerlo: ver cuántos escalones has bajado ya, cuánto has aprendido, cuántas cosas que antes costaban hoy salen solas.

Habrá semanas en las que no bajes nada y semanas en las que subas alguno. Forma parte del camino. Lo que cuenta no es la velocidad, sino la dirección y no soltarse de la barandilla.

Tu valor como persona no depende de lo que marque una báscula. Cuidarte no es castigarte: es tratar a tu cuerpo como a alguien a quien quieres llevar contigo muchos años.

Hoy, solo un escalón.
Mañana, el siguiente.

No hace falta subir la montaña de golpe.
Basta con bajar un escalón.

Si pesas entre 100 y 150 kilos, seguramente ya has probado dietas que prometían mucho y duraban poco. Este libro propone otra cosa: cambios pequeños, realistas y sostenidos, pensados para un cuerpo grande y una vida real.

Aprenderás a construir un plato que sacia, a moverte sin dañar tus articulaciones, a dormir mejor, a manejar el hambre emocional y a salir de las mesetas. Y tendrás un plan de 12 semanas, escalón a escalón, con registros listos para usar.

«Perder el 5–10 % de tu peso ya mejora la tensión, el azúcar, el sueño y las rodillas. Ese es el primer escalón.»

Bajando un escalón

Este libro es divulgativo y no sustituye la consulta con un profesional sanitario.

